★☆☆ 休克（0~1题）

有效循环血量↓→组织灌注不足→氧供给不足和氧需求增加（本质）、炎症介质释放（特征）

治疗最关键 / 首选：一般补充血容量（2010、2013、2023） —— 补平衡盐等晶体液；可联合人工胶体液（如羟乙基淀粉）、必要时输血

分度

休克早期 / 代偿期 / 轻度（2007、2022、2026） —— 失血量＜ 20%（＜ 800ml），收缩压正常或稍↑、舒张压↑、脉压↓

休克期 / 失代偿期“看 2”

	中度	重度
失血量	20%~40%	＞ 40%（＞ 1600ml）
脉搏	100~200 次 / 分	速（＞ 200）而弱（摸不清）
收缩压	90~70、脉压↓	＜ 70
神志	尚清楚、表情淡漠	意识模糊、昏迷

监测

尿量 —— ①尿量＜ 25ml/h 且尿比重增加：血容量不足致肾血管收缩（肾前性肾衰）；②血压正常但尿量仍少且尿比重低：肾性肾衰（2007）

乳酸、碱剩余 —— 评估缺氧、酸中毒、无氧代谢程度、预后

中心静脉压 CVP（5~10cmH_2O）

失血性休克补液原则

	CVP	BP
血容量严重不足：充分补液	↓	↓（＜ 90）
血容量不足：适当补液	↓	正常
容量血管过度收缩：扩静脉	↑	正常
心功能不全或血容量相对过多：强心、纠酸等	↑	↓
①补液试验→ BP ↑：血容量不足；②补液试验→ CVP ↑：心功能不全	正常	↓

感染性休克（2007、2010、2025）

继发性腹膜炎（腹腔空腔脏器穿孔损伤等）、AOSC、绞窄性肠梗阻、泌尿系感染、重症胰腺炎等

补充血容量 同时治疗感染灶 —— 常需外科引流；在有效抗生素前提下早期大剂量短时间用糖皮质激素；纠酸、心血管活性药